

2026년 제9차 약제급여평가위원회 사전 검토 보고

Leadership Brief | 2026.08.31 약평위 사전 점검

항목	내용
보고일	2026년 8월 31일
회의	2026년 제9차 약제급여평가위원회
회의 예정일	2026년 9월 3일(목)
보고 대상	보험약가 / Market Access Leadership
보고 목적	9차 약평위 예상 안건, 가격·협상 합의, MSD 관점의 우선 확인 포인트 정리

1. Executive Snapshot

한 줄 결론: 9차 약평위는 9월 7일 현 위원 임기 종료 직전 열리는 마지막 차수로, 장기 대기 항암 전환 후보와 비항암 희귀질환 단독 안건이 동시에 관찰 대상이다. 공식 사전 안건은 공개되지 않았으므로, Leadership은 “상정 여부” 자체를 D+1에서 가장 먼저 확인해야 한다.

핵심 메시지	Leadership Implication
사이람자·엘라히어·버제니오는 암질심 이후 약평위 전환을 기다리는 대표 항암 후보군이다.	세 품목이 포함되면 장기 대기 항암 파이프라인의 병목 해소 신호이고, 제외되면 경평소위·가격수용·회사 제출 준비 중 어디가 지연 요인인지 재점검해야 한다.
직전 8차 약평위는 하임파지 단일 비항암 희귀질환 품목에 대해 평가금액 이하 수용 시 적정으로 결론냈다.	9차도 항암 후보 없이 비항암·희귀질환 중심으로 구성될 가능성을 열어 두고, 약평위 capacity가 항암 전환만으로 움직이지 않는다는 점을 반영해야 한다.
파드셉+키트루다 병용은 약가협상 지연 신호가 지속되어 9차 신규 안건보다는 협상 타임라인 관리 이슈에 가깝다.	MSD 직접 영향은 “9차 상정”보다 요양상피암 병용요법의 가격분리·위험분담·고시 시점 확인에 있다.
10기 위원 구성과 하반기 개편 약가제도 적용이 맞물린 첫 전환 구간이다.	결과표의 품목 수, 조건부 문구, RSA 사용범위 확대 여부가 10월 이후 약평위 운영의 early signal이 된다.

2. 직전 차수 결과 — 이번 회의의 기준선

직전 8차 약평위는 항암 전환 후보 없이 결정신청 약제 1개 품목만 공개했다. 이 기준선은 9차에서 “밀린 항암 후보가 실제로 약평위에 도달했는가”와 “비항암 희귀질환 단독·소수 안건 패턴이 반복되는가”를 동시에 보게 만든다.

기준선	직전 공식 결과	이번 회의 연결 해석
제8차 약평위	하임파지프리필드펜주 150mg/mL(마스타시맙, 한국화이자제약): 35kg 이상 12세 이상 중증 A형·B형 혈우병 예방요법에 대해 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음	비항암 희귀질환 결정신청이 항암 전환 후보보다 먼저 처리될 수 있음을 확인. 9차에서도 단일·소수 품목 구성을 배제하지 않아야 한다.
제7차 암질심	브렌렙주 일부 병용요법 급여기준 설정, 다른 병용요법 급여기준 미설정; 보라니고·브루킨사 급여기준 설정; Docetaxel+Trastuzumab 급여기준 미설정	항암 급여 판단이 제품명보다 regimen·병용 파트너·환자군 단위로 세분화되고 있다. D+1 결과 검토도 품목 단위가 아니라 적응증·요법 단위로 읽어야 한다.
누적 미진입 후보	사이람자, 엘라히어, 버제니오 등은 직전 약평위 결과표에 포함되지 않았다.	9차 포함 여부가 단순 일정 문제가 아니라 경평소위 완료, 회사 가격전략, 재정영향 관리조건 준비도를 가능하는 지표가 된다.
조건부 적정 문구	최근 약평위에서 “평가금액 이하 수용 시 적정” 구조가 반복 확인된다.	결과 발표 시 급여 적정성 있음과 가격수용 조건부 적정을 분리해야 후속 협상 리스크를 정확히 볼 수 있다.

3. 9차 약평위 예상 안건 — Leadership Watchlist

HIRA는 약평위 사전 안건을 공개하지 않는다. 아래 watchlist는 직전 공식 결과, 암질심 이후 대기 기간, 공개 보도 신호, 9월 위원 교체와 하반기 약가제도 환경을 종합한 사전 점검이다. 최종 안건과 결과는 HIRA 공식 심의결과 발표 이후 확정한다.

우선순위	약제/범주	회사	영역	현재 판단	Leadership 관찰 포인트
High	사이람자(라무시루맵)	한국릴리	위암/위식도접합부 암	1차 암질심 이후 장기 대기. 6·7·8차 약평위 결과표에 미포함	결정신청 또는 RSA 확대 트랙 구분, 가격수용 조건, 위암 후속 치료제 비교 기준 확인
High	엘라히어주(미르베톡 시럽)	한국애브비	FR α 양성 백금저항성 난소암	5차 암질심 이후 약평위 전환 후보. 한 차례 이상 미상정 확인	희귀·난치성 항암제에서 행정 가속과 재정영향 관리 조건이 실제 약평위에 반영되는지 확인
Medium	버제니오정(아베마시 클립)	한국릴리	HR+/HER2- 조기 유방암 보조요법	5차 암질심 이후 전환 후보. 장기 투여·대상환자 선별 이슈 보유	OS 근거, 투여기간, 환자군 제한, 장기 재정영향 관리조건 확인
Medium	옵디보+여보이	한국오노·한국BMS	간세포암 1차 병용	암질심 설정 이후 약평위 전환 추적 후보	면역항암 병용요법의 약가 분담·비교약제 프레임이 키트루다 병용 전략에 주는 read-through 확인
Watch	비항암 희귀질환 결정신청 신약	복수 회사	혈액질환·신경희귀·소아희귀 등	8차 하임파지 단일 안건 패턴 재현 가능성	항암 후보 부재 시에도 신약 접근성·조건부 적정 문구·가격수용 gate를 확인
Watch	RSA 사용범위 확대 / 기존 급여약제 조정	복수 회사	기존 급여약제 관리	공개 사전 신호는 제한적이나 정기 운영 안건 가능	위험분담 확대 적정, 급여범위 확대, 약가 재조정 이 결과표에 포함되는지 확인

후보별 핵심 해석

사이람자 — 장기 대기 항암 전환 후보의 핵심 지표 사이람자는 암질심 이후 대기 기간이 가장 길다. 9차에 포함되면 위암 후속 치료제 접근성 확대와 가격수용 구조가 함께 읽히며, 제외되면 제출자료·경제성평가·회사 가격전략 중 병목 요인을 D+1에서 별도로 추적해야 한다.

엘라히어 — 난소암 희귀 표적치료제의 전환 속도 테스트 엘라히어는 희귀·난치성 항암제의 접근성 확대 기초가 실제 약평위 일정에 반영되는지 확인하는 후보이다. 상정 시 FR α 선별, 환자군 규모, 재정영향 조건이 결과 문구에 어떻게 반영되는지가 중요하다.

버제니오 — 조기 유방암 장기 보조요법의 재정영향 확인 포인트 버제니오는 장기 투여와 환자군 선별이 결론의 핵심이다. 급여 적정성 여부만이 아니라 대상군 제한, 투여기간, OS 근거 반영 수준을 함께 확인해야 한다.

비항암 희귀질환 신약 — 낮은 공개 노출을 보완해야 하는 탐색 범주 8차 하임파지 사례는 사전 매체 노출이 낮은 비항암 희귀질환 품목이 결과표의 전부가 될 수 있음을 보여줬다. 9차에서도 혈액질환·신경희귀·소아희귀 영역의 결정신청 신약을 D+1 결과표에서 넓게 스크리닝해야 한다.

4. MSD 관점의 주요 영향

영역	관찰 내용	MSD 대응 관점
키트루다 / 면역항암 병용	옵디보+여보이 또는 다른 면역항암 병용요법이 포함되면 병용 약가 분담·환자군 제한·급여기준 문구가 payer precedent가 된다.	파드셀+키트루다 협상과 별도로, 병용요법별 가격·RSA·고시 조건을 D+1에서 비교해야 한다.
위암	사이람자 상정 여부는 빌로이 이후 위암 영역의 치료순서·비교약제·가격수용 기준을 읽는 지표가 된다.	위암 라인별 치료제의 비용효과성 기준과 후속 협상 메시지를 브랜드·MA 관점에서 점검한다.
여성암	엘라히어·버제니오는 각각 난소암 희귀 표적치료제와 조기 유방암 장기 보조요법의 다른 payer question을 제기한다.	biomarker 선별, 장기 투여기간, 대상환자 제한이 재정영향 관리조건으로 어떻게 표현되는지 확인한다.

영역	관찰 내용	MSD 대응 관점
비항암 희귀질환	하임파지 이후 비항암 희귀질환이 약평위 안전을 차지하는 비중이 증가할 수 있다.	항암 중심 모니터링만으로는 FN이 발생할 수 있으므로 희귀혈액·신경·소아질환 결정신청 레이어를 유지한다.
운영·협상 타임라인	9월 위원 교체와 하반기 개편 약가제도 적용이 결과 구성과 조건부 문구에 영향을 줄 수 있다.	10월 이후 차수의 예측 기준을 조정하기 위해 품목 수, 결과 문구, 조건부 비율을 baseline으로 저장한다.

5. 결과 발표 후 확인해야 할 사항

확인 항목	왜 중요한가
사이랩자·엘라히어·버제니오 포함 여부	장기 대기 항암 후보가 9기 위원 임기 종료 전에 실제 약평위에 도달했는지 판단하는 핵심 baseline이다.
조건부 문구 발생 여부	“급여의 적정성이 있음”과 “평가금액 이하 수용 시 적정”은 후속 협상 리스크와 등재 속도가 다르다.
RSA 사용범위 확대 또는 급여범위 확대 안건	신규 결정신청과 기존 급여약제 조정은 가격·재정관리 의미가 다르므로 분리해야 한다.
비항암 희귀질환 품목 수	항암 전환 후보 미상정 시 예측 모델의 탐색 범위를 보완하는 지표가 된다.
파드셉+키트루다 협상·고시 신호	9차 약평위 안전과 별도로 MSD 직접 영향이 큰 협상 타임라인이다.
공식 결과표의 적응증·요법 단위	동일 제품이라도 regimen·line·biomarker에 따라 급여기준 설정 여부가 갈릴 수 있다.

6. Source & Caveat

본 보고서는 HIRA 공식 심의결과 공개자료, 직전 약평위·암질심 결과, 내부 누적 reimbursement dataset, 공개 매체 신호 및 하반기 약가제도 환경을 바탕으로 작성한 사전 검토 자료다. 약평위 사전 안건은 공식 공개되지 않으므로, 상정 여부·심의결과·후속 협상 의미는 HIRA 공식 심의결과 발표 후 D+1 리뷰에서 확정한다.

본 보고서는 특정 품목의 급여 가능성을 확정하지 않는다. D+1 결과 리뷰에서는 공식 결과표의 품목명, 성분, 회사, 효능·효과, 심의 결과 문구를 기준으로 본 watchlist의 상정 여부와 예측 baseline을 분리 평가한다.